



Yth.

1. SMF Anak
2. SMF Paru
3. SMF Jantung
4. SMF Jiwa
5. SMF Penyakit Dalam
6. SMF Saraf

SURAT EDARAN
NOMOR: 129.46/I-SE/DIR/II/2026

TENTANG
KRITERIA RUJUK BALIK PENYAKIT KRONIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1645/2024 tentang Rujuk Balik Penyakit Kronis ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Berita Acara (BA) Kesepakatan Tahun 2024, dijelaskan bahwa pasien dengan 9 (sembilan) penyakit kronis yang telah dinyatakan stabil sesuai kriteria lampiran I dan telah memperoleh obat kronis secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan wajib dilakukan PRB dan iterasi. Pasien yang telah mendapatkan PRB dan iterasi obat, jika pasien merasakan keluhan dan memerlukan pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di FKTP peserta terdaftar.

Apabila pasien penyakit kronis yang stabil dan tidak dilakukan PRB atau iterasi, berpotensi klaim tersebut tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan..

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Februari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes



Diabetes Mellitus	Hipertensi	Penyakit Jantung	Asma	PPOK	Epilepsi	Skizofrenia	Stroke	SLE
a. Tercapai target HbA1c < 7%, atau gula darah puasa (GDP) 80-130 mg/dl, atau gula darah 2 jam pp < 180 mg/dl dengan: 1) monoterapi ataupun kombinasi terapi; 2) terapi insulin basal dengan dosis < 20 unit; atau 3) monoterapi ataupun kombinasi terapi dengan terapi insulin basal dengan dosis < 20 unit, b. Komplikasi neuropati telah dilakukan pengobatan dengan neurotropik; c. Protein urin positif satu dengan monoterapi ataupun kombinasi; d. Tercapai target dengan gambaran Elektrokardiogram (EKG) normal; e. Tercapai target dengan <i>estimated Glomerular Filtration</i>	a. Tekanan darah < 140/90 mmHg, dalam waktu 3 bulan; b. Sudah dilakukan pemeriksaan kerusakan target organ dan tidak terdapat <i>Hypertension Mediated Organ Damage</i> (HMOD), yaitu: 1) Payah jantung; 2) Penyakit ginjal kronik stadium III-V (eGFR < 60 ml/min); 3) Penyakit jantung koroner; 4) <i>Stroke</i>; 5) Penyakit vaskular perifer; 6) Aritmia; dan/atau 7) Atrial fibrilasi, c. Bukan hipertensi sekunder, hipertensi pulmonal, dan/atau hipertensi pada kehamilan.	a. Penyakit Jantung Hipertensi 1) Tidak ada tanda gagal jantung (kongestif) berupa sesak napas atau nyeri dada dalam observasi selama 3 bulan; 2) Tidak ada aritmia; 3) Tekanan darah terkontrol baik pada waktu istirahat maupun aktivitas (TD <140/90 mmHg) dalam waktu 3 bulan; dan 4) Tidak terdapat keterbatasan aktivitas berupa sesak napas dan/atau nyeri dada selama observasi 3 bulan. b. Angina Pectoris 1) Dilakukan revaskularisasi (<i>Percutaneous Coronary Intervention</i> (PCI)/<i>Coronary Artery Bypass Grafting</i> (CABG)) sesuai indikasi;	a. Asma Stabil dan terkontrol menurut Astma Control Test >25 atau secara klinis apabila pasien dalam 4 minggu memenuhi seluruh parameter gejala dalam asma Symptoms control sebagai berikut : 1) tidak ada gejala harian asma lebih dari 2x seminggu 2) tidak terbangun malam hari akibat sesaknya 3) tidak memerlukan obat pelega lebih dari 2X seminggu 4) tidak ada keterbatasan aktivitas fisik karena asmanya b. Asma ringan dan sedang yang stabil yaitu tidak membutuhkan obat-obat berikut : 1) kortikosteroid inhalasi dosis sedang hingga tinggi (untuk dewasa	a) Secara klinis 1) skor Modified British Medical Research Council (mMRC) 0-1 atau skor COPD Assesment Test (CAT) kurang dari 10 2) Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak ada riwayat eksaserbasi atau 1 kali eksaserbasi (rawat Inap) atau >1 kali eksaserbasi kunjungan ke RS tanpa Rawat inap b) Pasien tersebut sudah di follow up dalam 1 bulan dengan : 1) mengerti rejimen pengobatan dan Teknik inhaler yang digunakan 2) mampu melakukan aktivitas fisik untuk kebutuhan hidup sehari - hari	a) bebas bangkitan epileptic selama 6 bulan b) telah tercapai dosis rumatan obat anti bangkitan (OAB)/obat anti Epilepsi (OAE) yang efektif c) Tidak ada efek samping OAB d) tidak sedang hamil dan menyusui	a) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-remisi (P1, P2, P3, N1, N4, N6, G5, G9) semua skor komponen lebih kecil atau sama dengan 3 b) Tercapai dosis fase rumatan antipsikotik 6 bulan tanpa kekambuhan c) Bukan episode pertama d) Usia 19-59 tahun (bukan anak remaja dan usia lanjut) e) Tidak ketergantungan zat, gangguan kepribadian, kodnisi medis umum yang tidak terkontrol, kasus forensic f) Tidak ada efek samping obat berat, deficit kognitif, gangguan kepribadian	a) telah dilakukan eksplorasi factor risiko stroke dan semua factor risiko telah terkontrol: 1) Tekanan Darah < 130/80 mmHg (bagi yang memiliki riwayat DM), dan <140/90 mmHg (bagi yang tidak memiliki DM) 2) GDP antara 80-130 mg/dL 3) Kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dL (bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung coroner), dan kurang dari 130mg/dL (bagi yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung coroner) 4) Kadar Asam urat <6mg/dL(PR), <7mg/dL (LK) 5) EKG: Hasil abnormal yang ditemukan telah ditata laksana sesuai kondisi medis 6) Vaskular imaging : dilakukan sesuai indikasi medis, hasil abnormal yang ditemukan telah ditatalaksana sesuai kondisi medis 7) Tidak ada factor risiko lain selain yang disebut diatas seperti kelainan sel darah, AVM dan Atrial Fibrilasi b) Telah melewati fase akut 6 bulan pada pasien	a) telah remisi (kriteria <i>Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000</i>(SLEDAI 2K) = 0) selama minimal 6 bulan b) Hanya menggunakan obat kortikosteroid dosis rendah (setara prednisone dosis < 5mg per hari) dan / atau hidroksiklorokuin c) Tidak dalam kondisi kehamilan



Rate (eGFR) > 60 ml/min; f. Tekanan darah terkontrol dengan 1 atau 2 obat anti hipertensi (sistolik <140 mmHg, diastolik <90 mmHg); dan g. Kolesterol <i>Low-density Lipoprotein</i> (LDL) < 100 mg/dL (<70 mg/dL bila risiko kardiovaskular sangat tinggi).		2) Tidak ada sesak nafas atau keluhan nyeri dada saat beraktivitas; 3) Sudah mendapat single atau dual antiplatelet pada pasien pasca PCI, beta bloker dosis optimal dan obat golongan statin intensitas tinggi; dan 4) Tekanan darah terkontrol (sistolik <140 mmHg, diastolik <90 mmHg). c. Infark Miokardium 1) Telah dilakukan revaskularisasi (<i>Percutaneous Coronary Intervention</i> (PCI)/<i>Coronary Artery Bypass Grafting</i> (CABG)) sesuai indikasi; 2) Klinis pasien stabil dengan gejala nyeri dada/angina maksimal Chronic Coronary Syndrome (CCS) kelas 1 selama evaluasi 3 bulan; 3) Kapasitas fungsional sesuai dengan NYHA I-II;	budesonide >800 mcg/hari, flutikason >500mcg/hari) c. Tidak memiliki penurunan fungsi paru berat (Forced Expiratory Volume 1 (FEV1) > 60% prediksi) d) Tidak ada riwayat intubasi dan / atau perawatan ICU karena asma dalam 12 bulan terakhir e) Tidak ada eksaserbasi berat dalam 12 bulan terakhir				dengan deficit neurologis yang membutuhkan pelayanan Rehabilitasi medis c) Bukan <i>stroke</i> serangan kedua dan seterusnya (srangan ulang)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



		4) Sudah mendapatkan terapi dual antiplatelet; 5) Sudah mendapatkan beta blocker dengan dosis optimal dengan target nadi istirahat < 70 kali permenit; 6) Telah mendapatkan obat golongan statin intensitas tinggi yang akan dilanjutkan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; 7) Telah mendapatkan obat golongan ACE-Inhibitor atau ARB jika kontraktilitas ventrikel kiri menurun (EF < 40 %) atau hipertensi; dan 8) Tekanan darah terkontrol (sistolik <140 mmHg, diastolik <90 mmHg). d. Gagal Jantung Kronik 1) Pasien bebas keluhan sesak nafas (<i>New York Heart Association Functional Classification I-II</i>)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		(NYHA Fc I-II)) selama observasi 3 bulan; 2) Volume cairan tubuh tidak bertambah selama 3 bulan berturut-turut; 3) Secara hemodinamik stabil dengan kriteria: tekanan darah >90/60 mmHg dengan produksi urin tercapai sesuai klinis; 4) Penyebab gagal jantung akut sudah teridentifikasi dan teratasi; 5) Telah mendapatkan terapi gagal jantung sesuai dengan pedoman tata laksana gagal jantung dan memantau klinis pasien agar tetap dalam keadaan euvolemia; 6) Pasien tidak dalam terapi warfarin (kasus dengan komorbid atrial fibrilasi atau paska operasi katup jantung); dan 7) Pasien tidak menggunakan <i>Implantable Cardioverter</i>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<i>Defibrillator (ICD), Cardiac Resynchronization Therapy Device (CRTD), Left Ventricular Assist Device (LVAD) atau alat pendukung sirkulasi mekanik lain.</i>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*) Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1645/2024

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Februari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes